医话医案

林忆平教授治疗中风后失语症临证经验

方永江[1] 徐海艺[2] 潘 雷[2] 林忆平[3△]

1. 昆明市中医医院，云南 昆明 650011；2. 云南中医药大学，云南 昆明 650500；
3. 云南省中医医院，云南 昆明 650021

【摘 要】 中风后失语症是中风常见后遗症之一，亦是最具破坏性的症状之一，该病严重影响了患者与外界的沟通，使患者难以回归社会及家庭。针灸治疗 PSA 具有一定的优势和理想的效果，已被推荐应用于 PSA 的临床康复与治疗。林忆平教授治疗本病审证求因，明确病机，提出“通督调神 - 开窍 - 调和阴阳”的治疗原则。

【关键词】 中风后失语症；审证求因；通督调神；分经选穴

【中图分类号】R249. 2/. 7 【文献标志码】A 【文章编号】1007 - 8517（2025）19 - 0068 - 06

DOI：10. 3969/j. issn. 1007 - 8517. 2025. 19. zgmzmjyyzz202519014

Professor Lin Yiping's Clinical Experience in Treating Post - Stroke Aphasia

FANG Yongjiang[1] XU Haiyi[2] PAN Lei[2] LIN Yiping[3△]

1. Kunming Hospital of Traditional Chinese Medicine, Kunming 650011, China;
2. Yunnan University ofChinese Medicine, Kunming 650500, China;
3. Yunnan Provincial Hospital of Chinese Medicine, Kunming 650021, China

Abstract: Post - Stroke Aphasia (PSA) is one of the most common sequelae of stroke and one of the most debilitating symptoms. This condition severely impacts a patient's ability to communicate with the outside world, complicating their reintegration into society and family life. Acupuncture and moxibustion have shown certain advantages and have achieved ideal results in treating PSA, making them recommended approaches for clinical rehabilitation and treatment. Professor Lin Yiping approaches this disease by examining the evidence, identifying the underlying causes, and proposing the therapeutic principle of "Tongdu, regulating the spirit, opening the orifices, and harmonizing yin and yang".

Key words: Post - Stroke Aphasia; Scrutinizing Symptoms to Identify the Root Cause; Dredging Governor Vessel and Regulating Spirit; Meridian - based Point Selection

中风是一种以脑组织缺血或出血性损伤症状和体征为主要表现的急性脑血管疾病，具有发病率高、致残率高、病死率高和复发率高的临床特征。而中风后失语症（post - stroke aphasia，PSA）是一种临床常见的获得性交流障碍综合征[1]，是中风常见后遗症之一，也是中风后最具破坏性的症状之一。PSA 影响大约三分之一的中风患者，其中 30% ~ 43% 患者受到失语症的长期影响[2-3]。研究[4]表明，PSA 是脑血管疾病造成中枢神经系统功能整合异常及神经传导通路受损，大脑优势半球受损发生的高级神经功能障碍，以语言表达、语言理解障碍为主要表现，伴或不伴有写作、认知等功能障碍，大部分患者以不同程度的语言功能受损甚至丧失，出现听、说、读、写、计算等方面的功能障碍。

PSA 属于中医学“喑痱”“不语”等范畴，中医学认为 PSA 的病位在脑，与心、肝、脾、肾关系密切，其病机为肝风、痰浊、瘀血等病理因素蒙蔽脑窍，脏腑亏虚不能濡养脑脉，致使脑脉不通、口舌经筋失养而失语[5]。本病严重影响了患

基金项目：第七批全国老中医药专家学术经验继承项目（国中医药人教函〔2022〕76 号）。

作者简介：方永江（1981—），男，汉族，硕士，副主任医师，研究方向为针灸临床疗效机制研究。E - mail：fangyongjiang81@163. com

指导老师：林忆平（1957—），女，汉族，本科，主任医师，研究方向为针灸临床运用研究。E - mail：469263244@qq. com

中国知网 https://www.cnki.net

者与外界的沟通，使得患者产生情绪障碍，影响了患者后期的康复训练和生活质量，使患者难以回归社会及家庭。

近年来，针刺治疗 PSA 已取得一定进展，且针灸具有疗效明显、价格便宜、运用灵活、不良反应少等特点。针灸治疗 PSA 可能涉及与认知过程相关的多种大脑机制，包括确定刺激显著性、调节认知控制、恢复语言网络、改善失语症结果、促进神经可塑性、减轻脑水肿和组织代谢紊乱以及增加代偿性语言回路中的突触发生等[6]。针刺治疗 PSA 具有一定的优势和理想的效果，已被推荐应用于 PSA 的临床康复与治疗。林忆平教授是云南省名中医，第六、七批全国老中医药专家学术经验指导老师，运用针灸治疗 PSA 取得了较好的疗效，报道如下。

1 审证求因，明确病机

PSA 是中风后遗常见的临床症状之一，中医学并无“卒中后失语”的明确病名，多将本病作为中风兼证阐述，根据其症状及体征特点，可归于“瘖痱”“舌喑”“不能言”“语言謇涩”等范畴。张仲景的《伤寒论》指出言迟由风导致，认为本病与风邪走窜脑络及舌窍相关；葛洪在《肘后备急方》[7]中提到痰积可导致言语涩滞；尤怡的《金匮翼》[8]阐述了失语与风、痰、瘀等致病邪气存在因果关系，提出言语不能为痰涎风气所致。

林忆平教授在长期临床实践中总结认为：中风一病，病变在脑，脑作为人体重要器官，既是元神之府又是“髓海”，脑髓充则神明健。而当风、火、痰、瘀等病理因素或由外袭，或由内生侵袭人体，蒙蔽损伤脑窍时则发为中风。脑窍伤则神机乱，神机乱则气机乱，气机乱则脏腑、官窍、筋肉的功能失常，因而出现肢体活动不利、言语蹇涩甚至失语等症。

言语发声受到多种脏腑关窍、发音器官甚至筋肉组织的协同调控。脑作为生命之枢，支配着人的意识思维记忆等精神活动，现代研究大多认为失语症是大脑损伤导致的语言障碍[9]。清代王清任指出“舌中有两管，内通脑气，即气管也，以容气之往来，使舌动转能言”[10]，脑气通于舌，脑窍闭阻，则语言失用。脑为“元神之府”，主宰和调控着生命活动，言语的表达交流，需神思调控而发出，因而脑神充，则发音器官运动正常，方能言语流畅。同时脑作为阴阳气血精明流注的通道，贮藏精髓，脑髓充沛是语言功能正常的重要物质基础。“人始生，先成精，精成而脑髓生”，精髓由肾精所化生，通过督脉上通于脑并聚集以充养元神之府，上行过程中依靠阳气的推动与气化，而督脉通过对全身阳气的有效支配，以发挥脑府神机之用，调控全身脏腑组织，继而保证言语功能的通利。另一方面言语通利与否关乎五脏平衡，清代著名医家张志聪言：“审其有音而言语不清，但责之心肝；能语而无声者，当责之脾肺；不能言语亦无声音者，此肾气之逆也。夫忧则伤肺，肺伤则无声矣；恚怒伤肝，肝伤则语言不清矣。”[11]因此五脏功能其任一环节的阴阳气血失和阻闭舌窍均是造成卒中后失语的重要因素。

林忆平教授认为本病虽然属于“失语”范畴，但究其根本是在“中风”后而发，所以病因病机上两者难以割裂，其发病多责之风、火、痰、瘀、虚；其病位在脑窍，累及舌咽，基本病机是窍闭神匿，神不导气，脑神失用，关窍闭阻，脏腑阴阳失衡，口舌经筋失养，导致其所主的功能活动失去支配。因而林忆平教授针对 PSA 提出“通督调神－开窍－调和阴阳”的治疗原则。

2 治疗特色

林忆平教授以“经脉所过，主治所及，腧穴所在，主治所及”“是动则病，是主所生病”等为理论基础，结合多年临床经验，形成了独具特色的组穴，取穴“风府、百会、风池、舌三针、涌泉、通里、三阴交、合谷、太冲”以达“通督调神，疏利舌本，开窍利言”之功。其治疗特色可具体概括为以下几点。

2.1 从“督”论治，通督调神 林忆平教授认为中风损脑，神机失调，从而影响脑对官窍的控制。清代王宏翰[12]认为“脑颅居百体之首，为五官四司所赖”，可见人体诸官窍正常的启闭功能依赖于脑神的控制。同时，风火痰瘀阻滞气血运行，气机不畅，可导致官窍无法正常启闭，因而发为中风后失语。针对 PSA 的患者，从“督”出发，取“风府、百会”督脉经穴，以达通调官窍之功。一方面，督脉与脑联系密切，“督脉入络脑”；另一方面督脉作为阳脉之海，通过对全身阳气的有效支配，以发挥脑府神机之用，调控全身脏腑组织及筋骨肌肉。《灵枢·海论》言：“脑为髓之海，其输上在于其盖，下在风府。”风府穴作为督脉循经入脑穴位，针刺风府可醒脑通督脉，养神调神机；百会位于头部高位巅顶处，深处即为脑之所在，针刺可以起到通督调神、健脑开窍的作用，

中国知网 https://www.cnki.net

作为精髓汇聚之处，还有健脑养髓的功效，脑髓得充则脑主感觉运动的机能正常，言语通利。

2.2 局部取穴，以开喑哑 林忆平教授根据局部取穴的原则，采用舌三针治疗 PSA。舌三针，即第一针（上廉泉），第二针左旁廉泉，第三针右旁廉泉[13]。第一针上廉泉又称舌本，通舌络。《医学纲目》中提到："治舌下肿，难言，口疮，舌纵，涎出，及舌根急缩：廉泉三分，得气即泻，灸三壮。"[14]廉泉位于任脉之上。任脉为阴脉之海，诸阴经均直接或间接交会于任脉，它能统领所有阴经，调节阴经气血，可改善中风后吞咽困难患者咽喉部的气血运行。舌三针由于其位置在舌根部，肾经、心经、脾经、心包经及任脉循行经过此处，可通过针刺疏通经络，调节气血脏腑。旁廉泉为廉泉左右旁开 1 寸的经外奇穴，针刺旁廉泉可增强刺激，与廉泉共奏通畅咽窍之功。

从其西医解剖学上看，廉泉穴位于结喉上方，舌骨上缘凹陷处，其深部为会厌，下方为喉门，针刺该穴深部有甲状舌骨肌、舌肌，颈前浅静脉，甲状腺上动脉、甲状腺上静脉；该穴深层有舌下神经分支[15]。针刺舌三针分别从神经兴奋与肌肉调节两个层面对整个语言神经通路进行加强刺激，进而形成良好的条件反射，构建良好的言语通路，以达开喑之功效[16]。《素问吴注》中有注解："唾出于廉泉二窍，二窍夹舌本。"[17]廉泉的位置与舌本密切相关，有研究[18]表明廉泉的作用对于相当于经外奇穴中的金津、玉液，金津和玉液作为舌系带两侧静脉处的经外奇穴，是脏腑经络气血交汇的关键节点。因此，廉泉作为另一舌下之两血脉交点，靠近咽喉部位，位置又处于舌下系带的血络，针刺能够起到利喉通痹开窍、利咽舒舌的作用。

2.3 分经选穴，通窍利言 《黄帝内经》曰"手少阴之别……系舌本""脾足太阴之脉……挟咽，连舌本，散舌下""肾足少阴之脉……循喉咙，挟舌本"，除此之外，有"肝者……脉络于舌本也"等论述。《舌胎统志》曰："盖舌为五脏六腑之总使，如心之开窍为舌，胃咽上接于舌，脾脉挟舌本，心脉系于舌根，脾络系于舌旁，肾肝之络脉，亦上系于舌本。"[19]心、脾、肝、肾、肺经脉的循行均直接与舌或其他发声器官密切相关，经脉气血运行不通则可影响语言的形成，导致言语謇涩或不能，因此林忆平教授选取与言语功能关系密切相关的经脉上的穴位，充分运用"经络所经之处，即为能治疗之病所"为基础原理，经络作为连接机体内外的网络，遍布全身，因此针刺相关穴位不仅能够解除舌咽部经气不利之状态，还能通过调节患者气血阴阳平衡，促进机体康健，经脉气血通利，脏腑阴阳调和，则言语自生，喑哑开窍。

心开窍于舌，言为心之声，中风后失语与舌窍、心窍关系密切。此外，心经经脉循行与舌根部相联系，手少阴心经循行"上挟咽"，手少阴经别"上走喉咙"，《灵枢·经脉》言"手少阴之别，系舌本"，因此，心经脉道充利，气血充盛，心神得养，则言语自生，舌窍通利。《马丹阳天星十二穴治杂病歌》有记载："通里腕侧后，去腕一寸中。欲言声不出……暴喑面无容，毫针微微刺，方信有神功。"[20]通里穴为手少阴心经的络穴，以通为治，故名"通里"。针刺可通心脉，益心气，具有宁心安神、利舌和营之功，善治暴不言。

《普济方》提到："脾中风者……舌强语涩。"[21]脾有气血生化之源之称，气血作为人体活动的基础，可以濡养脑髓，为舌体的正常活动提供充足的动力，故而《灵枢·经脉》中有"肌肉软，则舌萎"的描述；脾主肌肉，舌、咽喉等发音器官都是由肌肉组成，当脾发生病变，气血生化乏源，则可能导致舌咽肌在内的发音器官肌肉失去濡养，肌失所养则萎软无力，进而导致发音不利。《灵枢·经脉》记载脾脉"连舌本，散舌下""足太阴之脉，是动则病舌本强"，因此通过针刺脾经三阴交穴，不仅可以健运脾气，疏调经脉，从而恢复言语功能，还能通过肝脾肾三阴同补，与舌、喉咙等声音之机直接联系，达到通利三经之功，奏利窍开喑之功。

中风病的发病与肝胆经密切相关。肝风内动，血随气逆，上冲至清窍及脑部，可见中风后言语蹇涩。足少阳经与足厥阴经互为表里经，足胆经其经脉"下颈，合缺盆"，其经别"以上挟咽，出颐颔中"，因此，针刺胆经风池穴，可以疏通肝胆经脉之气，还能恢复言语功能及其受损的经络脏腑功能。风池为足少阳胆经穴，祛风要穴，是风邪侵入头脑的最后一道屏障，《类经图翼》云"风池治中风不语，牙关紧闭，汤水不能入口"[22]，《备急千金要方》也提到"风池主僻不能言"[23]，皆证明风池可以治疗中风遗留的语言障碍，针刺具有祛风通络、利咽开音功效。

《仁斋直指方论·声音》曰"肾为声音之根"[24]，肾气虚损，则声音便会虚浮无力。《灵枢经脉》提出："肾足少阴之脉……贯脊属肾络膀

中国知网 https://www.cnki.net

胱；其直者，从肾上贯肝膈，入肺中，循喉咙，挟舌本。”从中可知肾经沿咽喉挟于舌根部，且密切联系着肺、肝、心、肾四脏。涌泉作为足少阴肾经的井穴，针刺可以可达滋肾阴、益精髓、通舌窍、开喑哑之功，同时可调肝气、利肺气、开心气，助横膈之升降，开喉舌之窍闭，用于各种病变所引起的暴喑、失语。该穴的取用也有“上病下取”之意，百会配涌泉是目前临床治疗言语障碍最常用的组穴之一[25]。《灵枢·终始》云“病在上者下取之……病在头者取之足”，选取四肢肘膝关节以下的腧穴，是经脉所过，主治所及原则的体现，同时，基于标本根结理论，四肢肘膝以下的部位对应经脉的“本”之所在，为脉气始发之地，头部的位置对应经脉的“标”“结”之所在，为脉气结聚之地，两穴一上一下合用，加强经脉间的气血流注，合而共奏通利脑窍之效，进而改善言语功能。

中医认为“气”是人体生命的物质基础。肝主疏泄，调畅气机，从而调解人的精神情志活动，语言表现具有宣畅通达的特性，则与肝主疏泄的生理特点是一致的。肝主疏泄气机功能正常，肝气调和，言语才能清晰流利。肺主气，司呼吸，语言的正常需要气息的支持。“肝生于左，肺藏于右”，肺主降而肝主升，二者升降协调平衡才能保证气机的调畅。气机调畅，血才得以安和。肝藏血，在体合筋，肝的经筋直接连于舌本，肝的生理功能正常，筋得血养，则舌体运动灵活，言语流畅。手太阴肺经“上出缺盆，循喉咙”，喉咙作为发音部位之一，其气血相和，则咽喉清，声音亮。而肺与大肠相互络属，二者经气相通相合，因此刺激肺和大肠的经脉和腧穴有交通反应。PSA 作为中风后遗症，多数患者兼半身不遂等肢体疾患，常规来讲半身不遂的治疗多取四肢穴位，以疏导肢体经气。而对于失语患者来说，四肢末端为各经阳气所“根”，阴气之“本”的所在部位，为经气的根本，故取四肢穴位不仅能够调节肢体经络气血，还能治疗头身疾患如失语等症。林忆平教授临床上常用“四关”穴治疗多种疾病，“四关”穴，合谷、太冲是也。二者为原穴，针刺原穴可以通达原气，调节脏腑经络功能。《针灸穴名解》中说：“四关，以其能大开通也。”[26]因此其配伍具有开通之意。合谷为手阳明大肠经原穴，手阳明经是多气多血之经，太冲为足厥阴肝经原穴，足厥阴是多血少气之经，太冲合谷相配，一血一气，一阴一阳，一下一上，不仅能使气机升降相因，而且能交通阴阳，共同调整人体内的气血阴阳的平衡，达到调和气血、疏通经络、开窍利言之功。

3 治神守神，疏调情志

林忆平教授在治疗中风后失语患者的过程中发现许多患者在治疗过程中伴随着言语恢复缓慢、与人交流困难、情绪不佳等情况，而治疗的重点大多在于减少患者带残生存率，提高患者言语功能，即重视“形”的治疗，而对于患者“神”的治疗鲜少关注。在大量临床实践中发现，治疗中风后失语，如忽略精神因素，仅依靠针药治疗，疗效常不稳定。有研究[27]显示形神疾病治疗的最佳方法是形神同治，中风病则是形神同病的典型代表。形神同治能更好地促进中风后的康复进程，有效缩短治疗时间，是中风病不可或缺的治疗方法。林忆平教授认为，疏调情志对于治疗中风后失语，尤为重要。

首先应调医者之“神”，《素问·宝命全形论》曰“凡刺之真，必先治神”，治神之意一是指医生在治疗过程中应专一精神，心无他务。《灵枢·行针》曰“其神易动，其气易往”，故在治疗过程中医生还应当密切关注患者的情况，引导患者安神定志、人静守神，引导经气直达病所。林忆平教授在给患者的诊治过程中非常重视治神与守神，她常说治神不易，守神更难，在施针过程中不要急于调气，调针感，而应先治其神，后调其气，使神气相合，方能气至病所，针到效显。

其次治患者之“神”。张景岳言：“凡治病之道，攻邪在于针药，行药在于神气。”俗话说“心乱百病生，心静百病愈”，治病先治心，让患者放下心结，满怀信心而愉悦地进行治疗，常能事半功倍。事实上，PSA 的患者治疗恢复过程往往不可一蹴而就，患者在治疗过程中常常面临着“有口难说”“有意难表”等困难，长此以往，所思所想所表均郁结于心，患者心理压力越来越大，更不利于其恢复，形成恶性循环。《素问·宝命全形论》言：“凡刺之真，必先治神。”还有第二层意思是指要让患者精神放松，情绪稳定，积极配合医生，如此则心神安，气血和，经气易至，疗效才显。此外患者需要的不仅是医者的鼓励，更重要的是疏调好患者与家人的关系，得到家人的配合，让家人多关心、鼓励患者，增强患者的信心，让患者及其家人都积极参与疾病的治疗。

林忆平教授强调要将外在语言功能的修复与

中国知网 https://www.cnki.net

内在的意识、思维等精神神态的调整结合起来，形神兼顾，进而提高中风后失语的临床疗效。

4 典型案例

张某，男，67 岁。2022 年 2 月 15 日初诊。主诉：左侧肢体活动不利伴言语蹇涩 1 月余。患者于 2022 年 1 月 18 日无明显诱因突发头晕目眩，随即跌倒在地，不省人事，家人立即送往当地医院就诊，行头颅磁共振检查示：双侧基底节区、右侧丘脑梗死灶，诊断为“急性脑梗死”，予住院治疗，经溶栓、抗凝、营养神经、稳定血压等西医治疗后，病情有所好转，遂出院，但仍遗留左侧肢体活动不利以及明显失语症状，无法清晰表达言语，仅能发出简单音节，严重影响日常生活交流。故来我院寻求中医针灸康复治疗。刻下症见：神清，面色晦暗，左侧肢体活动受限，言语不能，语声低微，能发出“啊”“嗯”等简单音节，但不能完整叙述词语及语句，理解力尚可，能通过点头、摇头等方式表达意愿。口眼歪斜，饮水偶有呛咳，偶有头昏头晕、流涎，饮食稍减，夜眠不安，二便尚调，舌淡暗，苔白微腻，舌下络脉瘀滞，脉弦滑。

查体：左侧上下肢肌力 2 + 级，肌张力增高，右侧上下肢肌力、肌张力正常，左侧上下肢轻瘫试验（+），左侧巴宾斯基征（+）。波士顿失语症检查法（BDAE）分级：1 级。

西医诊断：脑梗死恢复期；运动性失语。中医诊断：中风 – 中经络（痰瘀阻络型）。取穴：风府、百会、风池、舌三针、涌泉、通里、三阴交、合谷、太冲。配穴：丰隆、血海，随证加减。

操作方案：①针刺操作：患者先取坐位，将选定穴位用 75% 酒精棉球消毒。选用一次性针灸针。风府穴向下颌方向刺入 0.5 ~ 0.8 寸，缓缓进针，得气后将针退至皮下，先向右下倾斜针柄，使针身和皮肤呈 45° ~ 60°，深度不超过直刺深度，稍加捻转再将针退至皮下，随后向左下倾斜针柄，进针深度和捻转同前，最后将针尖再次退至皮下，向下颌方向刺入，要求达到患者的枕部和颈上段部强烈的麻胀感为宜。百会穴向后 15°平刺得气后施以小幅度捻转补法使针感放射到整个头部。舌三针针刺时，单手快速进针，针尖向舌根方向呈 45° ~ 60°，斜刺入进针约 1 ~ 1.2 寸，在得气的基础上，行提插捻转泻法，使患者舌根有酸麻胀痛感，并扩散至口咽部。风池穴进针前先揣穴，即按揉风池穴稍向外上方靠近枕骨下缘处，当患者感颈项前部有酸胀感时快速进针，缓慢调整针尖方向及针刺深度进行搜气，直至针感沿颈项上下、咽喉部传导为宜。涌泉穴针刺时先嘱患者轻咳一两声，在患者咳声发出瞬间，迅速将针直刺 1 ~ 1.5 寸；通里穴直刺 0.5 寸，感局部酸麻胀循心经下行至无名指及小指。三阴交直刺进针 1 ~ 1.5 寸，施提插补法，至患侧下肢抽动为宜。合谷、太冲直刺 1 ~ 1.5 寸。配穴按照虚补实泻的原则进行操作。针刺得气后留针 30 min。每周针刺 5 次，1 个疗程 2 周。②在针刺过程中，要注意引导患者练习发音，同时对于患者的发音反馈需要给予正向的鼓励，并告知患者接下来的治疗需要其主动参与，然后不时对患者进行心理暗示，使患者心身放松，增加患者在治病过程中的参与感，加强了患者对疾病恢复的自信心，达到形神共调。

2022 年 3 月 2 日二诊：患者语言不利较前改善，患者已由开始仅能发出“啊”“嗯”等单音节语气词恢复到可以说出简单的词语，例如“喝水”“厕所”等，但言语尚不清晰，发音过程缓慢；左侧肢体不利情况较前改善，左侧上下肢肌力 3 + 级，左侧上下肢轻瘫试验（±）。BDAE 分级：2 级。继守前方针刺治疗 2 个疗程，嘱患者家属增加每日与患者的言语交流。

2022 年 4 月 2 日三诊：患者精神状态明显好转，面部神态渐渐生动，言语功能明显改善，可与家属进行对话，语句虽然断续，但交流无障碍，发音速度增快，且较前清晰。左侧肢体不利情况明显改善，左侧上下肢肌力 4 ± 级，在助行器辅助下可下地缓慢走步，已无饮水呛咳情况。BDAE 分级：4 级。守前针刺处方，继续针刺治疗 2 月，每周 2 ~ 3 次，适当增加中等难度词汇语句训练。半年后电话随访，患者诉活动功能恢复良好，可以日常交流。

按语：林忆平教授认为，患者年高体弱，平素情绪容易激动，机体内伤日久导致脏腑功能失调，五官清窍失濡，痰浊瘀血内生，加之平素血压控制不佳，再逢患者情绪激动，肝风任意上扰，致气血逆乱，痰瘀窜乱，留滞脑窍，窍闭神逆，脑神失用，关窍闭阻，口舌经筋失养，发为本病。因此诊疗过程中，一方面，首先以“通督调神”为总领，选取“风府、百会”二穴，脑神调则气机和，气机和则气血畅，气血畅则经络通；次予“舌三针”配合简单发音训练以达利咽舒舌之功；再次予“风池、涌泉、通里、三阴交、合谷、太冲”对应肝心脾肺肾脏腑，脏腑通调则各司其职，

中国知网 https://www.cnki.net

阴阳气血调和，舌体咽窍得以濡养，促进言语功能的恢复。另一方面，林忆平教授注重通过循序渐进的言语功能锻炼，逐步改善发音进程，同时配合适当的心理疏导，调节患者情志，最终通过针刺治疗、功能锻炼、精神调摄三者结合取得了良好的疗效，使患者恢复了言语功能，达到身心健康状态。

5 小结

PSA 作为卒中后常见后遗症，其发病人数随着中风发作率逐年上升，但其治疗方面还存在着较大困难，患者病情迁延，生活质量、心理状态均受到明显影响。综上所述，林忆平教授谨守病机，以“通督调神 - 开窍 - 调和阴阳”为治疗原则，通过特色组穴针刺治疗以达开窍利喑，疏调舌本，调和脏腑阴阳气血之功。此外林忆平教授在治疗过程中注意形神共治，调医者之“神”，使神气相合，气至病所，针到效显。安患者之“神”，使心神安宁，气血调和，经气易至，疗效显著。最后从患者预后出发，配合肌音训练，充分发挥患者的主观能动性，通过医者 - 患者 - 家属三方配合，放松身心，增强疗效，共同促进患者声音功能的恢复。

参考文献

[1] HARVEY S, CARRAGHER M, DICKEY M W, et al. Dose effects in behavioural treatment of post - stroke aphasia: a systematic review and meta - analysis [J]. Disability and Rehabilitation, 2022, 44 (12): 2548 - 2559.

[2] PALMER R, DIMAIRO M, COOPER C, et al. Self - managed, computerised speech and language therapy for patients with chronic aphasia post - stroke compared with usual care or attention control (Big CACTUS): a multicentre, single - blinded, randomised controlled trial [J]. The Lancet. Neurology, 2019, 18 (9): 821 - 833.

[3] SAXENA S, HILLIS A E. An update on medications and noninvasive brain stimulation to augment language rehabilitation in post - stroke aphasia [J]. Expert Review of Neurotherapeutics, 2017, 17 (11): 1091 - 1107.

[4] 张通，李胜利，白玉龙，等. 卒中后失语临床管理专家共识 [J]. 中国康复理论与实践，2022，28 (1): 15 - 23.

[5] 李晓琳，常静玲. 论中风后失语辨证中的“痰”与“窍” [J]. 中华中医药杂志，2016，31 (9): 3450 - 3454.

[6] ZHUO B, DENG S, LI B, et al. Possible Effects of Acupuncture in Poststroke Aphasia [J]. Behavioural Neurology, 2023 (2023): 9445381.

[7] 葛洪. 肘后备急方 [M]. 长春：吉林科学技术出版社，2024：255.

[8] 尤怡. 金匮翼 [M]. 北京：中国中医药出版社，1996.

[9] 肖娜，王盛春. 针刺治疗中风后运动性失语的机制研究进展 [J]. 上海针灸杂志，2024，43 (2): 162 - 166.

[10] 王清任. 医林改错 [M]. 欧阳兵，张成博，点校. 天津：天津科学技术出版社，1999：34.

[11] 张志聪. 黄帝内经灵枢集注 [M]. 矫正强，王玉兴，王洪武，校注. 北京：中医古籍出版社，2012：456.

[12] 王宏翰. 医学原始 [M]. 张明锐，李鸿涛，点校. 北京：学苑出版社，2015：30.

[13] 江钢辉，李湘力. 靳氏舌三针治疗中风运动性失语症疗效观察 [J]. 上海针灸杂志，2008 (7): 5 - 6.

[14] 楼英. 医学纲目 [M]. 北京：中国中医药出版社，1996：350 - 351.

[15] 王瑀，林自立，梁英业，等. 针刺治疗卒中后失语的机制探讨 [J]. 实用中医内科杂志，2023，37 (3): 1 - 3.

[16] 高洋，黄岩，刘培培，等. 言语康复训练联合督脉针刺合舌三针对卒中失语患者语言功能认知水平的影响 [J]. 安徽医学，2024，45 (6): 714 - 718.

[17] 黄帝内经素问吴注 [M]. 北京：学苑出版社，2012：127 - 129.

[18] 张子璇，王迅. 探议廉泉穴 [J]. 中国民间疗法，2022，30 (9): 7 - 9.

[19] 裘沛然. 中国医籍大辞典 [M]. 上海：上海科学技术出版社，2002：1535.

[20] 杨继洲. 针灸大成 [M]. 天津：天津科学技术出版社，2017：79.

[21] 朱橚. 普济方集要 [M]. 余瀛鳌，林菁，田思胜，等编选. 沈阳：辽宁科学技术出版社，2007：35 - 39.

[22] 张景岳. 类经图翼 [M]. 太原：山西科学技术出版社，2023：277.

[23] 孙思邈. 备急千金要方 [M]. 魏启亮，郭瑞华，点校. 北京：中医古籍出版社，1999：917.

[24] 杨士瀛. 仁斋直指方论精要 [M]. 贵阳：贵州科技出版社，2008：366.

[25] 王伟华，张蕴，张维保. 主客原络配穴法针刺治疗中风后言语功能障碍疗效观察 [J]. 上海针灸杂志，2012，31 (6): 401 - 403.

[26] 高式国. 高式国针灸穴名解（修订版）[M]. 北京：中国中医药出版社，2017：53.

[27] 秦明臻，刘婷婷，熊雪娇，等. 基于“形神一体”理论探讨中风病全周期防治思路 [J]. 北京中医药，2022，41 (7): 720 - 724.

（收稿日期：2025 - 01 - 16 编辑：刘 斌）

中国知网 https://www.cnki.net